Клинические рекомендации

Злокачественные новообразования губы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C00** — Злокачественное новообразование губы
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/553_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Критерии диагноза 3

3.2 Физикальное обследование 3

3.3 Инструментальные исследования 3

4. Лечение 4

4.1 Тактика лечения по стадиям 4

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Диспансерное наблюдение 5

5.2 Показания к госпитализации 5

6. Источник и актуальность 5

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 5

1. Основные положения

- Рак губы исходит из эпителия красной каймы; в 85–90% случаев поражается нижняя губа, опухоль располагается несколько в стороне от срединной линии. Морфологическая верификация является обязательным критерием диагноза.
- Основным методом радикального лечения является хирургический, с одномоментной пластикой при необходимости. Дистанционная или внутритканевая лучевая терапия по радикальной программе — при отказе от операции или противопоказаниях к ней.
- **Лимфодиссекция при T1–T2 N0 по глубине инвазии**
  1. **менее 2 мм**: операция только на первичном очаге, шейная диссекция не рекомендуется;
  2. **2–4 мм**: решение индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла;
  3. **более 4 мм**: операция и селективная лимфодиссекция, минимально уровни 1–3.
- Адекватным считается удаление с отступом от края резекции до видимой опухоли **1,5 см и более**; чистый край — **5 мм и более**, близкий — **менее 5 мм**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Рак губы — злокачественная опухоль из многослойного плоского эпителия красной каймы нижней или верхней губы. Поражение кожи и слизистой оболочки обусловлено дальнейшим распространением опухолевого процесса.

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиологические факторы

1. неблагоприятные метеорологические факторы: длительная солнечная инсоляция, резкие колебания температуры;
2. курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание смесей (насвай, орех бетель);
3. фоновые процессы: плоская лейкоплакия, эритроплакия, хронические язвы и трещины губ, хейлиты.

Мужчины болеют чаще женщин (3:1). В 2021 г. распространённость составила 22,5 на 100 тыс. населения, впервые диагноз установлен в 1881 случае; в 83,5% заболевание выявляется на I–II стадиях. Максимум заболеваемости — в возрасте 55–75 лет и старше.

2.3 Классификация

Распространённость оценивается по классификации TNM 8-го издания AJCC для эпителиальных опухолей полости рта; глубина инвазии не является толщиной опухоли.

Группировка по стадиям

Стадия	Сочетание T, N, M
0	Tis N0 M0
I	T1 N0 M0
II	T2 N0 M0
III	T3 N0 M0; T1–T3 N1 M0
IVA	T1–T3 N2 M0; T4a N0–N2 M0
IVB	любое T N3 M0; T4b любое N M0

Стадия	Сочетание T, N, M
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Опухоль обычно локализуется несколько в стороне от срединной линии, в углах рта возникает крайне редко; в 85–90% поражается нижняя губа.

1. **экзофитные формы (папиллярная, бородавчатая)** — развиваются на фоне продуктивного дискератоза, долго; опухоль имеет вид папилломы, множественных мелких выростов, цветной капусты
2. **эндофитные формы** — развиваются на фоне деструктивного дискератоза: уплотнение, трещина, эрозия или язва; появление по краям валикообразного венчика свидетельствует об озлокачествлении

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, физикального и инструментального обследования; морфологическая верификация является обязательным достоверным критерием диагноза.

3.2 Физикальное обследование

Осмотр включает бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфатических узлов и оценку нутритивного статуса. Перед лечением выполняются общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмма.

3.3 Инструментальные исследования

1. **УЗИ лимфатических узлов шеи** — всем, с пункцией пальпаторно неизменённых узлов
2. **УЗИ первичного очага** — всем — для определения толщины опухоли и планирования операции на лимфоколлекторах шеи

Всем выполняется КТ и/или МРТ поражённой области с внутривенным контрастированием — для оценки распространённости, глубины инвазии, костной инвазии на челюсти и основание черепа.

1. **КТ органов грудной полости** — при распространённом раке с поражением регионарных узлов; при невозможности — рентгенография лёгких
2. **сцинтиграфия костей** — при подозрении на метастазы в кости
3. **ПЭТ-КТ** — при III–IV стадиях — для исключения отдалённых метастазов

Морфологическое заключение отражает

1. размеры и распространённость первичной опухоли, глубину инвазии;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. периваскулярную, перилимфатическую, периневральную инвазию;
4. статус регионарных узлов (pN) с числом исследованных и поражённых узлов, экстранодальное распространение (ENE);
5. расстояние до ближайшего края резекции в мм;
6. экспрессию PD-L1 — при нерезектабельном процессе и паллиативном лечении.

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

Хирургическое вмешательство является основным методом радикального лечения; удаление образования выполняют с одномоментной пластикой при необходимости. При Tis возможна мукозэктомия с применением физических методов: лазер, радиочастотная аблация, плазменная коагуляция, фотодинамическая терапия.

При отказе от операции или противопоказаниях

1. дистанционная лучевая терапия по радикальной программе;
2. внутритканевая лучевая терапия самостоятельно или в сочетании с ДЛТ;
3. фотодинамическая терапия.

При периневральной, периваскулярной, лимфатической инвазии в операционном материале показана адъювантная лучевая терапия; при положительном крае — повторная операция или ЛТ.

Тактика по стадиям

Стадия	Лечение
T1–T2 N0, глубина инвазии менее 2 мм	операция только на первичном очаге, шейная диссекция не рекомендуется
T1–T2 N0, глубина инвазии более 4 мм	операция на первичном очаге и селективная лимфодиссекция (минимально уровни 1–3); при 2–4 мм — индивидуально, возможна биопсия сторожевого узла
T3–T4a N0; T1–T4a N1–N3	операция на первичном очаге с шейной лимфаденэктомией; при невозможности операции — ДЛТ или ХЛТ, внутритканевая ЛТ в комбинации с ДЛТ/ХЛТ

Объём шейной лимфаденэктомии

1. **N0** — селективная на стороне поражения, уровни 1–3; не менее 18 удалённых узлов; при срединной опухоли или переходе за среднюю линию — с двух сторон
2. **N1, N2a–b, N3** — радикальная на стороне поражения, уровни 1–5; при срединной опухоли — дополнительно селективная с контралатеральной стороны, уровни 1–3
3. **N2c** — радикальная с двух сторон, уровни 1–5

При высокой вероятности или наличии метастазов в лимфатические узлы шеи выполняют профилактическую ипсилатеральную лимфаденэктомию; при срединной опухоли или переходе за среднюю линию — двустороннюю. При ранних стадиях рака губы метастазирование в узлы встречается редко, в среднем менее 10%.

Целью операции является статус R0. Адекватным считается отступ от края резекции до видимой опухоли **1,5 см и более** или отрицательный край замороженного среза; интраоперационное исследование срезов проводят, если свободная зона **менее 1,5 см** или граница опухоли нечёткая.

1. чистый край: **5 мм и более** от инвазивного края опухоли;
2. близкий край: **менее 5 мм**.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Физикальный осмотр и сбор жалоб

1. первый год: **каждые 1–3 месяца**;
2. второй год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й год: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: **ежегодно** или при жалобах.

Объём обследования

1. УЗИ лимфатических узлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
2. КТ головы и шеи — по показаниям и при недоступности зоны осмотру;
3. рентгенография или КТ органов грудной клетки — **каждые 12 месяцев**;
4. тиреотропный гормон после облучения шеи — **каждые 6–12 месяцев**.

Наблюдение у стоматолога показано до, во время и после специализированного лечения; проблемные зубы удаляют **не менее чем за 2 недели** до начала лечения.

5.2 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения: хирургического, лучевого, лекарственного.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Злокачественные новообразования губы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	553_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Российское общество клинической онкологии; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.